Graham Music

Nature culturali

Attaccamento, sviluppo socioculturale, emozionale e cerebrale del bambino

alpes

Capitolo 3
Nati per essere in relazione

Immaturità

Il bambino si presenta molto immaturo alla nascita e nei primi mesi di vita può fare ben poco senza aiuto altrui; per sopravvivere, infatti, ha bisogno di cure, possibilmente costanti, sul piano fisico ed emotivo. In questo capitolo illustrerò come i bambini siano comunque predisposti all'interazione sociale e hanno a disposizione tutta una serie di capacità utili in tal senso. Essi sono in grado di suscitare negli altri umani le risposte di cui hanno bisogno ed hanno una capacità straordinaria di rispondere all'ambiente sociale in cui si trovano. I bambini nascono con diversità temperamentali e genetiche, a cui corrisponde una grande variabilità con cui gli adulti rispondono ai bambini. La vita umana si sviluppa grazie ad una delicatissima interazione tra natura e cultura, ovvero dall'incontro tra un insieme di potenzialità ereditarie e le influenze culturali, sociali e personali degli adulti presenti nella vita del bambino.

Ci sono tutti i presupposti perché questo tipo di scambio inizi subito dopo la nascita. Klaus (1998) ha descritto le capacità straordinarie del neonato, che già pochi minuti dopo la nascita si dirige verso il seno materno per trovare il capezzolo, avanzando centimetro dopo centimetro spingendo con le gambe contro l'addome della madre. Alla fine vi arriva vicino, spalanca la bocca e, dopo vari tentativi, riesce a farla aderire perfettamente sull'areola del capezzolo. Moltissimi bambini riescono a compiere questo passaggio, a condizione che non siano stati lavati dopo la nascita o che siano nati senza eccessivo intervento medico, poiché l'odore è fondamentale per questo processo. Infatti, se per esempio si lava il seno destro, il bambino si muoverà verso il sinistro e viceversa, e se sono stati puliti entrambi i seni, il bambino sceglierà quello su cui vi è il liquido amniotico della madre.

I bambini nascono predisposti a riconoscere l'odore della madre, come descritto in questo esperimento. Il neonato era posto in una culla con due bocchettoni che soffiavano aria, a destra e a sinistra; però, l'aria che arrivava dal lato sinistro era stata fatta passare sopra dei tamponi imbevuti del latte materno, mentre da destra arrivava al neonato l'odore del latte di un'altra madre. Bene, i bambini si giravano e si sforzavano di spostarsi verso il lato da cui arrivava l'odore della propria madre, e quando i tam-

poni erano scambiati di lato, i loro sforzi si orientavano di conseguenza (MacFarlane, 1975).

Questi movimenti istintivi non sono un semplice riflesso, ma illustrano la capacità che il neonato ha di adattarsi e il suo desiderio attivo di mantenere la vicinanza alla propria madre. Attraverso il contatto pelle a pelle, il corpo della madre mantiene la temperatura del bambino, anche non coperto da indumenti, ad un livello ideale, dal momento che si viene a creare un sistema omeostatico tra i due. Durante l'allattamento al seno, si rilascia ossitocina che stimola sentimenti di amore, e permette anche di ridurre il dolore. Si è visto che la stimolazione di un maggiore contatto tra madre e bambino riduce il rischio di abbandono. Nelle madri a rischio di disturbi della genitorialità, è bastato aumentare di qualche ora al giorno il tempo trascorso con il proprio bambino per osservare in molti casi una riduzione di un quinto del tasso di abbandono, abuso e trascuratezza (O'Connor *et al.*,1980). Per alcuni genitori il bonding non è immediato e una certa sollecitazione al legame può fare una notevole differenza. Le ricerche mostrano che facilitare il legame madre-bambino, per esempio attraverso l'allattamento al seno, riduce di molto il tasso di abbandono del bambino (Dumas *et al.*, 2013); sostenere le neo-mamme può fare la differenza (Olds, 2012) per aiutare a stabilire vicinanza fisica, attivare il rilascio di ormoni come la **vasopressina** e l'ossitocina, favorire il sorgere di sentimenti migliori non solo verso il bambino, ma anche nel bambino.

Il bonding: l'essere umano non è una papera

Si è diffusa la convinzione errata che il legame debba crearsi immediatamente a scanso di danni irreversibili, idea, questa, divulgata grazie agli studi etologici sugli animali. Le papere, per esempio, si legano e seguono la prima creatura che vedono, di qualunque specie essa sia, e le pecore memorizzano l'odore dei propri agnelli e rifiutano di farsi avvicinare da agnelli con un odore diverso. Gli esseri umani però sono diversi e non hanno un periodo prestabilito subito dopo la nascita durante il quale deve avvenire il bonding. Gli esseri umani potrebbero legarsi con quasi tutti i bambini, non solo i propri, e raramente tale legame si stabilisce immediatamente, di solito ci vuole tempo perché si sviluppi. Bowlby (1969), il padre della teoria dell'attaccamento, ha scoperto che quelli che lui chiama ***legami affettivi*** (nel senso di emotivi) nascono in seguito a cure costanti e alla vicinanza che dura nel tempo.

La dedizione materna non può essere data per scontata; il bonding umano è un processo generalmente graduale e reciproco, e può essere facilitato con un adeguato sostegno. Questo emerge già durante la gravidanza quando nella madre si sviluppa un maggiore coinvolgimento verso il bambino dopo aver visto l'immagine ecografica (de Jong-Pleij *et al.*, 2013) e, in modo particolare, se si sviluppa in modo corretto. Le possibilità di sopravvivenza dei neonati crescono poiché sono predisposti a guadagnarsi l'attenzione delle figure di cura spesso grazie a tratti del viso attraenti. Il presbite di Sumatra, un primate, nasce per esempio di un bianco splendente con una striscia scura lungo tutto il corpo. In molti pensiamo che i bambini siano adorabili e questo sentimento si estende ad altre creature che ricordano i bambini, come le foche, per esempio, che hanno occhi molto grandi.

L'allattamento al seno facilita il bonding e diminuisce la reattività della donna agli stressor psicologici, probabilmente in parte grazie al rilascio di ossitocina (Johnson e Young, 2015), ma è anche di grande beneficio per il bambino sul piano immunologico grazie al colostro, in particolare, quel fluido nutriente che arriva prima del latte. Le madri naturali, come si sa, non sono le uniche che allattano al seno. Nell'Europa medievale e aristocratica il tasso di sopravvivenza dei bambini nutriti dalle **balie** era molto vicino a quello dei bambini allattati dalle madri naturali e favoriva l'aumento della fertilità e la sopravvivenza dei neonati. In Francia il ricorso alla balia era molto diffuso in tutte le classi sociali alla metà del diciottesimo secolo (Fildes, 1988) e rimane tuttora una pratica comune in alcune parti del mondo.

Durante l'allattamento si rilasciano anche altri ormoni utili, come la **prolattina** che fa aumentare il sentimento di protezione e di sollecitudine. E in effetti è stato dimostrato che le madri che allattano al seno diventano protettive in modo più aggressivo (Hahn-Holbruk *et al.*, 2011) il cosiddetto effetto 'mamma orso'. Il livello di prolattina aumenta perfino nel padre, prima e dopo la nascita (Gettler *et al.*, 2012). L'ossitocina è presente solo nei mammiferi, e in misura maggiore in quelli monogami, poiché aiuta la formazione dell'attaccamento. Può persino indurre sentimenti positivi che ci rendono ciechi nei confronti dei difetti dell'altro e anche troppo fiduciosi! Le madri con alti livelli di ossitocina sono tendenzialmente più sensibili nei confronti dei figli, creano un legame migliore, un attaccamento ravvicinato, dimostrando uno sguardo più amorevole e un contatto fisico più affettuoso (Galbally *et al.*, 2011). Il tipo di amore comune e quasi ossessivo, che le madri spesso hanno verso i loro bambini, ha caratteristiche simili non solo all'innamoramento ma anche ai sintomi ossessivo-compulsivi. Leckman (1994) fa notare che il controllo vigile che una madre mette in atto quando, per esempio, controlla costantemente la culla per assicurarsi che il bambino respiri, assomiglia al modo in cui i pazienti ossessivo-compulsivi controllano, per esempio, se hanno spento il

forno. C'è persino un collegamento tra livelli elevati di ansia, ossitocina e quella che viene definita *malattia d'amore* (Clark-Polner e Clark, 2012). In genere, però, l'ossitocina predispone a sentimenti positivi, non all'ansia, e alti livelli di ossitocina durante l'infanzia portano ad avere un maggior numero di recettori dell'ossitocina, programmando così il corpo a produrne e ad usarne di più in seguito.

Se si è fortunati, il tempo trascorso con un bambino dopo la nascita stimola intimità e forti sentimenti di affetto reciproco e i bambini si calmano toccandoli (Fairhurst *et al.*, 2014) e se portati in braccio, poiché si regola il battito cardiaco e la pressione del sangue (Esposito *et al.*, 2015). Le madri che accarezzano il loro bambino sono apparentemente più protette dalla depressione (Sharp *et al.*, 2012). Alcune madri però faticano a formare legami stretti, per ragioni sociali, se per esempio vivono in condizioni di estrema povertà, o psicologiche, se sono depresse o vittime di violenza. In verità l'ossitocina sembra promuovere il legame solo in un contesto che sembra sicuro e non pericoloso (Bartz *et al.*, 2011; Olff *et al.*, 2013), e naturalmente in un contesto di violenza, serie difficoltà economiche, o malattie mentali la probabilità di costruire un legame si riduce. Dunque si va oltre la mera ossitocina; emerge infatti che a seconda della qualità della relazione madre-bambino si attivano sezioni diverse del circuito cortico-limbico cerebrale (Swain *et al.*, 2014). Inoltre, regioni specifiche del cervello si attivano a seconda che si guardi il proprio bambino rispetto ad un bambino estraneo (Wan *et al.*, 2014), e i ricercatori lavorano ad identificare quali reti cerebrali si attivano nelle madri che hanno creato un buon legame con i loro bambini (Feldman, 2015).

Predisposti ad interagire

I bambini piccoli cercano di stimolare in modo attivo risposte di bonding negli adulti e sono predisposti per mettersi in relazione con persone e volti. Fino a non molto tempo fa si credeva che i bambini nascessero ciechi ma in realtà vedono sin dalla nascita sia pure ad una distanza di circa trenta centimetri tra il petto e la faccia (von Hofsten *et al.*, 2014). Molte delle abilità percettive iniziali sono mirate a permettere loro di diventare degli esseri sociali. Decine di anni fa Brazelton e Tronick (1980) dimostrarono come i bambini siano predisposti a relazionarsi in modo differente con gli esseri umani e gli oggetti inanimati, il che è stato confermato da una ricerca recente (Baker *et al.*, 2014). Si filmarono i neonati mentre una scimmietta giocattolo sospesa a un filo si muoveva verso di loro, fino ad essere quasi a portata di mano, e poi si allontanava. I bambini reagivano

alla presenza dei giocattoli con eccitazione, ma come a qualcosa da esplorare, toccare, afferrare, muovendosi a scatti. Essi, invece, rispondevano alle madri in modo completamente diverso, come ad una persona con cui interagire, aspettandosi una risposta, sorridendo, ricambiando o distogliendo lo sguardo. I neonati generalmente mostrano di preferire i visi agli oggetti inanimati (Kwon *et al.*, 2013), anche se spesso i bambini che diventeranno autistici fanno eccezione (Jones e Klin, 2013). Appena dopo nati, si può attrarre la loro attenzione verso il disegno in bianco e nero di un viso, ma non verso varianti più confuse e meno delineate. Madre e bambino spesso cercano gli occhi dell'altro dopo la nascita e i neonati preferiscono anche una foto del viso materno piuttosto che quello di un estraneo (Wagner *et al.*, 2013). In verità, questione preoccupante, a tre mesi essi sembrano perfino scegliere facce della loro stessa razza (Gaither *et al.*, 2012). Preferiscono anche guardare foto di volti con occhi aperti piuttosto che chiusi, volti orientati nel verso giusto (Dobkins e Harms, 2014) e distinguono le forme simili ai visi, ad es. linee che rassomigliano ad occhi, bocca e naso. Riconoscere i volti può indurre risposte positive.

La capacità di riconoscere i volti è innata ma si attenua in assenza di un apposito impulso. Bambini vedenti di madre cieca guardano meno negli occhi (Senju *et al.*, 2015), mentre i bambini allevati in orfanotrofi deprivanti in termini di emozioni presentano una capacità molto minore di riconoscere i volti (Nelson *et al.*, 2013) e minore attività nelle aree cerebrali corrispondenti (Moulson, Fox *et al.*, 2009). I bambini tuttavia nascono con capacità potenzialmente enormi di riconoscere le emozioni ed imparare la socialità, soprattutto attraverso i suoni ed i volti. Se si mostrano ai bambini le foto di un gran numero di visi e, successivamente, foto di volti che hanno già visto, più una che non hanno visto prima ma che si avvicina molto ad una *media* tra quelle già viste, saranno maggiormente incuriositi da quest'ultima (Walton e Bower, 1993). È interessante osservare che i bambini generalizzano sebbene abbiano maggiori probabilità di riconoscere espressioni emotive se le hanno viste prima in un genitore (Walker-Andrews *et al.*, 2011). Questa capacità può essere usata attivamente per identificare di chi fidarsi o a chi aprirsi; neonati di sette mesi sono già in grado di individuare stati emotivi complessi come la paura grazie ad alterazioni della sclera, la parte bianca del bulbo oculare (Jessen e Grossmann, 2014). Bambini più piccoli sono perfino in grado di riconoscere le emozioni altrui semplicemente guardando i movimenti del corpo quando le facce sono nascoste (Zieber *et al.*, 2014).

I neonati riconoscono sia la voce del padre che della madre ma mostrano una chiara preferenza per la quella della madre (Lee e Kisilevsky, 2014). Il ritmo cardiaco del feto rallenta quando ascolta una registrazione della

voce della madre, ma non cambia se la voce è di un estraneo, (Kisilevsky *et al.*, 2009), come fa il neonato (Rand e Lahav, 2014), dimostrando un'impressionante capacità di riconoscere e ottenere quello di cui ha bisogno. E anche le onde cerebrali sono diverse tra quando ascolta la voce della madre e quella di un'altra donna anche se gli esterni faticano a distinguerle. Field spiega tuttavia che tali capacità sono affievolite sia nel feto che in un neonato di una madre depressa, ed essi ottengono risultati peggiori nei test di discriminazione delle facce e delle voci (Field 1984). Alcune esperienze o situazioni, quindi, possono far accendere o spegnere queste capacità potenziali.

In un affascinante esperimento, De Casper e Spence (1986) hanno individuato il normale ritmo di suzione del neonato, che varia da bambino a bambino. Hanno poi trasmesso con un altoparlante registrazioni della voce della madre, ma solo mentre i bambini succhiavano ad un ritmo inferiore a quello solito; quando succhiavano al ritmo normale, invece, veniva trasmessa la voce di un'altra donna. Fu molto evidente che i neonati succhiavano il seno scegliendo deliberatamente un ritmo che permetteva loro di sentire la voce della propria madre. Anche succhiando ad un ritmo più veloce del solito ascoltavano la sua voce: in ogni caso cambiavano il loro comportamento per essere più vicini alle loro madri. I bambini erano perfino capaci di riconoscere la storia del Dott. Seuss, *Il gatto nel cappello*, letta dalla madre e che avevano già ascoltato mentre erano nell'utero, da un'altra storia del Dott. Seuss con stile e ritmo simili ma diverse parole. Queste capacità potrebbero essere centrali per la sopravvivenza del bambino, aiutandolo a localizzare le madri e a stimolare l'interazione, capacità che a loro volta potrebbero ravvivare il desiderio della madre di interagire.

I bambini di poche settimane hanno una capacità di apprendimento molto sviluppata, e sanno tradurre esperienze vissute da una modalità sensoriale (la vista) in un'altra (il tatto), e viceversa. In un vecchio esperimento (Meltzoff e Borton, 1979) alcuni bambini furono bendati e vennero dati loro tettarelle di forma diversa, alcune sferiche e altre con delle protuberanze, e i bambini familiarizzarono con esse attraverso il tatto e il modo in cui le sentivano in bocca. Quando tolsero loro le bende, i bambini guardavano più a lungo la tettarella che avevano appena succhiato, il che significa che avevano incredibilmente riconosciuto, usando la vista, qualcosa di cui prima avevano avuto esperienza attraverso sensi diversi, il contatto e la suzione. Qualcosa di simile avviene con altre modalità sensoriali, come il suono e la forma, (Ozturk *et al.*, 2013). Analogamente a neonati molto piccoli piace guardare altri bambini cui viene accarezzato il viso se nello stesso momento anche il loro viso è accarezzato ma allo stesso ritmo (Filip-

così la vita prevedibile e comprensibile. A differenza di quanto sostenuto inizialmente, il bambino sa che quello che vede (per esempio il seno) è uguale a quello che percepisce (per esempio il seno dal quale ha succhiato). I neonati hanno straordinarie capacità di comprendere il mondo umano.

Imitazione infantile e contingenza

I bambini nascono, potenzialmente, con numerose competenze sociali, ma perché queste si sviluppino è necessaria un'interazione sintonica. Per esempio i neonati sono in grado di imitare gli adulti già pochi minuti dopo la nascita (Meltzoff, 2007). In alcuni esperimenti i genitori tirano fuori la lingua e i bambini guardano con attenzione, e dopo molti sforzi anch'essi tirano fuori la lingua. Un bambino nato da soli dieci minuti non sa di avere una cosa chiamata lingua, ma in qualche modo traduce ciò che vede in un gesto fisico. Neonati di soli due giorni sanno imitare tutta una serie espressioni facciali come sorridere, accigliarsi e mostrare sorpresa, anche se questa capacità è più forte nei primi giorni. Ricerche recenti hanno messo in discussione l'idea che la capacità di imitare del neonato sia innata e non appresa (Oostenbroek *et al.*, 2016), anche se in realtà non si discute la capacità in sé.

La ricerca ha dimostrato che quando imitano i neonati comunicano (Nagy *et al.*, 2013), rispondendo attivamente a movimenti volontari di protrusione della lingua e non imitando movimenti involontari come gli starnuti. Il loro ritmo cardiaco aumenta mentre imitano i gesti degli adulti ma, cosa interessante, rallenta quando cercano di indurre un adulto a imitarli, il che indica che hanno una diversa intenzionalità (Trevarthen e Aitken, 2001). I bambini imparano presto a imitare anche suoni e gesti. Nei primi mesi di vita i bambini sorridono giusto quanto è necessario ad indurre il sorriso della madre e non di più (Ruvolo *et al.*, 2015).

È incredibile come sia meno probabile che bambini di un anno imitino adulti in apparenza non affidabili (Poulin-Dubois *et al.*, 2011). La visione al rallentatore di filmati di bambini mostra come i loro arti si muovono a tempo con la cantilena usata dagli adulti quando parlano il *maternese*; da qui si sviluppa una **sincronizzazione** [entrainment], per cui madre e bambino si adattano ai rispettivi ritmi. Si instaura dunque una forma di mutua risonanza, e ciascuno funziona da cassa armonica dell'altro ma anche da facilitatore dello scambio successivo. Il bambino così fa esperienza della regolazione fisiologica ed emotiva e impara anche a conoscere il mondo relazionale in cui vive. In questo modo un neonato sperimenta regole nei

specialmente, e con maggiore efficacia, se qualcuno canta per noi (Trehub *et al.*, 2015a), e la musica può attivare tutti i diversi processi di ricompensa e le abilità comunicative (Wang, 2015). Non tutti i bambini ovviamente hanno genitori capaci di entrare in sintonia con loro, ma anch'essi imparano, e velocemente, cosa aspettarsi nella vita dagli adulti.

Queste capacità imitative sono più che reazioni riflesse o un copiare superficiale; a poche settimane dalla nascita, i bambini sono già capaci di impegnarsi in una sorta di conversazione, simile al tubare dei piccioni, traendo energia dal ritmo dell'altro. Potremmo dire che i bambini imparano chi sono attraverso i gesti e le espressioni facciali dell'altro. Le madri rispondono ai gesti del loro bambino in un sesto di secondo e il bambino a sua volta replica entro un terzo di secondo (Beebe e Lachmann, 1997), il che fa pensare ad un sistema interattivo più che a due individualità separate. I neonati producono più suoni simili al linguaggio quando la madre sorride, specialmente quando il sorriso è sincero, quello che alcuni chiamano **sorriso Duchenne** (Hsu *et al.*, 2001), e neonati più sintonizzati con lo sguardo della madre vocalizzano e sorridono in modo più positivo (Markova e Legerstee, 2006). Nei primi mesi, si spende molta energia per la regolazione fisiologica, si dorme molto per esempio, ma tra i due e i sei mesi la socievolezza cresce velocemente, portando a più vocalizzazioni e sguardi interattivi.

Attraverso l'imitazione e grazie al fatto che ricevono risposta ai propri segnali, i bambini piccoli imparano che sono in grado di produrre effetti sugli altri e cominciano a sviluppare un certo senso della loro capacità di agire [agency] e a provare piacere per quanto riescono a far accadere. I bambini di due mesi scalciano di più se vedono un effetto del loro gesto, come far muovere un oggetto, ma mostrano meno piacere quando l'oggetto si muove indipendentemente da loro (Ramey e Watson, 1972). Allo stesso modo, quando le loro azioni ricevono una risposta contingente che poi si interrompe, i bambini protestano, poiché a loro piace sentire che producono un effetto.

All'inizio i bambini preferiscono una **contingenza** quasi perfetta (Fonagy, 2004): se tirano fuori la lingua e l'altro fa lo stesso, essi sono felici. Imitazione forse non è la parola più adatta poiché le due parti variano sempre leggermente l'altezza e il tono della voce e l'espressione. A tre mesi preferiscono una contingenza meno perfetta e sono sempre più attratti da nuove interazioni che forniscono un livello di sincronia alto anche se meno perfetta. Infatti una contingenza troppo perfetta è vista come un segnale di minore sensibilità (Bornstein e Manian, 2013), o anche di ansia e trauma (Beebe *et al.*, 2012). In una contingenza meno perfetta un ge-

leggermente l'altezza, ne viene fuori un gioco. Il bambino percepisce gli altri come partner interattivi e a questo punto iniziano le cosiddette danze reciproche, che evolvono poi nella capacità di scherzare e prendere in giro che il bambino acquisisce più tardi, nel primo anno di vita. Reddy (1991) descrive bambini di otto mesi che scherzano, fingono di offrire qualcosa e poi la ritirano, capaci di capire e confondere le aspettative degli altri in un contesto giocoso. I bambini allo stesso modo si accorgono se qualcuno si comporta in modo strano (Liberman *et al.*, 2014) ma hanno bisogno di un compagno empatico con cui interagire per sviluppare pienamente capacità relazionali così raffinate.

Sintonizzazione, regolazione dell'affetto e marking

Durante molte delle prime esperienze, dal cambio del pannolino all'allattamento o al bagno, che rilassa e prepara a dormire, i genitori provano a comprendere gli stati fisiologici ed emotivi del proprio bambino, e a comunicargli a loro volta di averli compresi. Lo psicoanalista Bion (1977) ha chiamato **contenimento** il processo grazie al quale una madre può introiettare, elaborare e modulare un'esperienza del bambino e poi restituirla in una forma gestibile e ricevibile. I genitori leggono i segnali del bambino e rispondono, spesso verbalmente (per es.: 'Oh ora sembri un po' nervoso, mi chiedo cosa c'è che non va'). Se i genitori rispondono in modo pronto e senza troppa ansia ai loro piccoli, questi imparano ad avere fiducia e a credere che il mondo sia un posto sicuro e affidabile; i bambini piccoli hanno bisogno di un adulto che li conforti e li regoli, e quando questo accade imparano subito ad aspettarsi che un conforto simile sia disponibile quando ne hanno bisogno.

Quando un bambino è arrabbiato, il suo caregiver spesso mostra in modo empatico che lo comprende imitando i suoni che produce. Gergely e Watson (1996) hanno chiamato questo comportamento **marking**, che consiste nel riflettere, amplificandoli leggermente, i sentimenti del bambino, quasi facendo i buffoni, e trasmettendo loro il senso di una mente sintonizzata con loro dal punto di vista emotivo, che tollera i loro sentimenti e li rimanda. Questo è cruciale anche nel lavoro terapeutico con i bambini (Music, 2005). Il marking come il contenimento (Bion, 1977), permette di comunicare che quell'emozione del bambino, sia essa rabbia o tristezza, è stata compresa e non è soverchiante. Nell'empatia o nel marking possiamo sospirare nello stesso modo in cui lo fa un bambino angosciato, produrre suoni che richiamano i loro, muoverci al ritmo dei loro gesti. Non si tratta, però, di semplice **rispecchiamento**, poiché il bambino si sentirebbe

peggio, e non meglio, se gli riflettessimo il suo disagio; quando invece questo è compreso e tollerato da un altro, fa meno paura.

Se un bambino angosciato viene preso in braccio e tranquillizzato nel primo anno di vita, piangerà meno degli altri dopo un anno (Hubbard e van Ijzendoorn, 1991), poiché sperimenta che le sue emozioni sono state tollerate, contenute, modulate ed impara anche a non essere sopraffatto dalle esperienze. Impara anche a gestire i sentimenti, e quindi si può dedurre che stia interiorizzando la capacità genitoriale. Queste prime esperienze, l'essere compresi da un altro, facilitano lo sviluppo della capacità di comprendere sé stessi; la soggettività e la consapevolezza di sé si sviluppano solo se la consapevolezza emozionale è raccolta da un altro. Alcuni bambini piccoli non vivono mai quest'esperienza, pensiamo al tragico caso dei bambini gravemente trascurati o abusati che spesso non sviluppano in modo adeguato le capacità autoriflessive e le capacità di regolazione interpersonali. A molti dei bambini inclusi nella lista dei casi preoccupanti dei professionisti del settore è mancato proprio quel tipo di esperienze interpersonali 'nutrienti' qui descritte.

Alcuni dubbi sull'istinto materno: abbandono e infanticidio

In molti adulti le aree del cervello specializzate nella ricompensa (per es. la **corteccia orbito-frontale mediale**) rispondono entro un settimo di secondo a volti di neonati, ma non di adulti, sconosciuti (Kringelbach *et al.*, 2008).

Questo fa pensare a qualcosa di simile all'istinto materno, ma è importante mettere da parte i sentimentalismi. In molte specie di primati i genitori, soprattutto le madri, devono decidere, cosa non facile, se investire o no, la grande quantità di tempo, energia e dedizione che sono necessari per allevare un bambino. Hrdy (1999) riporta molti esempi di femmine di primati e di umani che hanno sacrificato la loro prole. Dall'analisi dei rapporti redatti dagli investigatori nell'arco di cinque anni nell'Inghilterra del XIX secolo, risultava che su 3.900 morti, soprattutto di neonati, più di 1.100, a seguito di inchiesta giudiziaria, vennero considerati casi di omicidio. Si tratta di una questione delicata poiché secondo i nostri valori tali azioni sono da ritenere immorali. Tuttavia Hrdy è convinta che l'infanticidio sia stato un comportamento comune e perfino adattivo. Nelle società di cacciatori-raccoglitori, dove le condizioni di vita consentivano di sostenere un solo nuovo nato ogni quattro anni, i bambini nati prima del previsto erano spesso uccisi, così come accadeva per uno di due gemelli

sono essere direttamente o indirettamente ascritte a una strategia materna per ridurre gli alti costi del loro allevamento.

In un ospizio per trovatelli nella Firenze del XV secolo erano abbandonati in media novanta bambini all'anno, ma in un anno di carestia ne vennero lasciati ben 961. I tassi di sopravvivenza non sono mai stati buoni in queste strutture: in Russia nel 1767 furono accolti più di 1.000 bambini abbandonati, ma il 91% di questi non sopravvisse al primo anno. Nella Grecia contemporanea l'abbandono dei bambini è aumentato massicciamente durante la recessione economica e l'austerità (Carassava, 2014). Scheper-Hughes (1992) ha studiato le favelas brasiliane, dove il tasso di mortalità infantile è molto alto; vi sono malattie e condizioni economiche difficili, e ha constatato che le madri si allontanano dai figli che non hanno buone possibilità di sopravvivenza. Le madri descrivevano alcuni bambini come forti, mentre di altri dicevano che mancava loro la volontà di vivere ed erano spesso lasciati morire in un modo che agli occhi di un occidentale può sembrare crudele.

Il momento in cui il piccolo nasce è spesso fondamentale: si è visto che una madre a volte abbandona il suo piccolo se le circostanze non sono favorevoli, e tuttavia alleva con amore e dedizione un altro bambino nato in tempi più propizi. Madri più giovani che vivono in situazioni difficili abbandoneranno con maggiore probabilità la prole, forse perché confidano nel fatto che avranno altre opportunità di avere figli, e sappiamo che l'omicidio di neonati è più spesso compiuto da madri giovani e povere che non hanno ricevuto un aiuto adeguato (Friedman *et al.*, 2005), il che è un argomento a sostegno di un intervento tempestivo piuttosto che di una condanna.

L'opinione di Hrdy è che moltissime madri nella storia dell'umanità non hanno potuto concedersi il lusso di amare ogni bambino nato. Alcuni teorici evoluzionisti (Hagen, 1999) sostengono perfino che la propensione alla depressione postnatale, con il rilascio di ormoni particolari, è il modo che la natura si è trovata per permettere alla madre di fare un passo indietro dal legame con quel bambino particolare in quel momento particolare. Forse ci sono delle buone ragioni per investire nell'allevamento dei bambini solo quando le risorse e i sistemi di assistenza sono migliori, o quando i pericoli sono minori; un'idea molto stimolante per coloro che lavorano con genitori e bambini.

Sincronizzazione, cultura, e diventare parte della comunità

Nelle prime settimane e mesi di vita i neonati si acclimatano ed adat-

ad adattarsi al ciclo giorno-notte dei loro genitori e sincronizzano il loro respiro e battito cardiaco con quello degli adulti che li circondano. I neonati separati dalle madri per alcuni giorni e poi restituiti si sincronizzano rapidamente con il ciclo sonno-veglia delle loro madri entro pochi giorni, anche se pare che i maschi impieghino più tempo (Sander, 2007).

Le potenzialità biologiche interagiscono con le aspettative culturali e familiari, dando origine a pattern relazionali diversi. Il pianto dei bambini è una tipica area in cui il biologico e il sociale sono legati indissolubilmente; è uno strumento di segnalazione innato, ma i bambini piangono solo se hanno un ascoltatore sensibile. I neonati possono non sapere perché sono angosciati e chi li cura deve spesso capire se il pianto è dovuto, ad esempio, alla dentizione, a fame, o al desiderio di essere presi in braccio. I genitori imparano a comprendere il loro bambino e i bambini a loro volta imparano ad adattarsi ai loro genitori. Se i bambini con attaccamento sicuro piangono quando sono angosciati e imparano ad aspettarsi aiuto, per altri il pianto non induce una risposta di conforto e così imparano a non piangere.

Il pianto potrebbe essere un segnale comune tra i primati ma può essere insopportabile e gettare alcuni genitori nella disperazione. In Occidente ai bambini sono spesso diagnosticate le coliche, ma spesso quello che importa non è quanto piangono ma l'effetto sui genitori e sulla loro capacità di confortare il bambino (Barr *et al.*, 2014). Tra i fattori che proteggono dalle coliche vi sono l'avere un partner cui appoggiarsi, meno stress durante la gravidanza e minore isolamento sociale. Si è visto che se le madri tengono in braccio i bambini più a lungo dopo averli allattati, il pianto si riduce in modo considerevole, rispetto al gruppo di controllo che piange per lo stesso periodo di tempo. La colica è più rara nelle società non occidentali (Lee, 2000) e ricerche che hanno comparato diverse culture mostrano che i bambini cominciano a piangere in misura simile, siano essi olandesi, americani o boscimani! Varia però la durata del pianto e la velocità di risposta alla loro sollecitazione. La cultura naturalmente interagisce con la biologia. Gli americani ignorano circa il 46% degli episodi di pianto dei bambini nei primi tre mesi di vita, mentre in alcune culture i bambini sono attaccati al seno entro 15 secondi dal momento in cui cominciano a piangere (Ainsworth e Bell, 1977). Nondimeno non dovremmo sottovalutare la terribile angoscia che scaturisce dal pianto di un bambino e che spesso porta al suo maltrattamento (Barr, 2014).

Il pianto si è evoluto per permettere ai bambini di comunicare l'angoscia ed è per lo più biologicamente adattivo, ma non quando fa allontanare il genitore. Anche le caratteristiche temperamentali però hanno il loro peso

to evoca risposte diverse a seconda delle aspettative culturali e dello stato mentale dei genitori. Molti adulti preferiscono bambini *buoni* e tranquilli ma ciò non vale sempre. In un periodo di forte siccità negli anni '70, alcuni bambini Masai erano stati etichettati come *difficili* o *facili*, con riferimento a quanto fossero adattabili, calmi o gestibili (Wermke e Friederici, 2005). Un ricercatore identificò i dieci bambini più facili e i dieci più difficili, e quando tornò tre mesi dopo la siccità era peggiorata e ritrovò dei due gruppi solo 13 bambini; sette di questi, già malnutriti, morirono nei mesi successivi; ma solo uno dei sette apparteneva al gruppo dei difficili. I bambini nervosi e piagnucolosi forse avevano ottenuto più attenzioni, o più latte e avevano mostrato una maggiore combattività e questo probabilmente aveva salvato loro la vita. Nello studio di Scheper-Hughes (1992) sulle favelas brasiliane con alti tassi di mortalità infantile, i bambini etichettati come combattivi ricevevano maggiori attenzioni ed erano quelli che sopravvivevano. Hrdy (1999) racconta qualcosa di simile in una relazione antropologica sugli Eipo della Nuova Guinea, una cultura che ha usato l'infanticidio per tenere sotto controllo la crescita della popolazione. Una madre aveva dichiarato di non desiderare l'arrivo di un'altra bambina e si preparava ad abbandonarla. Aveva avvolto, dunque, la neonata in foglie di felce che aveva legato con una corda mentre la bambina piangeva; era andata via ma non aveva gettato il fagotto nel cespuglio come sarebbe stato normale fare. Due ore dopo era ritornata, aveva tagliato il cordone ombelicale e ripreso con sé la bambina, spiegando che la figlia era troppo forte. Alcune volte ha senso piangere e questo modo di comunicare indica quanto i bambini siano attivi, comunicativi ed esseri sociali sin dalla nascita.

Punti chiave:

- i neonati sono attrezzati a relazionarsi, riconoscere e rispondere attivamente all'odore, alla voce e ai gesti della madre dalla nascita in poi;
- si adattano attivamente al loro ambiente sociale, imparando sia cosa possono aspettarsi da esso sia come poterlo influenzare attivamente;
- il bonding avviene gradualmente e non è garantito, e il rifiuto dei neonati non è inusuale. Alcuni neonati ricevono attenzioni sintoniche e risposte adeguate, ma ciò non capita a tutti e dipende dal livello di sostegno ai genitori e dalla loro storia personale;
- i neonati massimizzano la loro attrattività per sopravvivere. Molte

rotondo, fronte prominente, inducono sentimenti positivi e di protezione e scoraggiano le aggressioni;

- i neonati sono in grado di riconoscere facce, odori e suoni e si adeguano alla cultura nella quale nascono, che si tratti di una tribù africana di cacciatori raccoglitori o di una famiglia europea della classe media;
- un neonato può assorbire le atmosfere emotive psicologiche e culturali come una spugna, cogliendo e adattandosi alle atmosfere e alle aspettative emozionali;
- i neonati si 'sincronizzano' al ritmo del loro ambiente e microsecondi dopo averli conosciuti, apprendono gli schemi di comportamento che possono attendersi in un contesto fortemente interattivo o in uno più riservato;
- tutti i bambini imparano a sopravvivere e a crescere bene nel mondo particolare in cui si trovano usando la grande varietà di risposte di cui l'evoluzione li ha dotati.